

# 참아야 할 증상과 연락해야 할 증상

대부분의 불편감은 조절 가능하지만, 심한 복통·탈수·저혈당·알레르기 증상은 빠른 판단이 필요합니다.

# 심한 복통은 단순 소화불량으로 넘기지 않습니다

췌장염과 담낭질환은 드물지만 반드시 확인해야 하는 위험 신호입니다.

상복부 통증이 심하고 지속되거나 등으로 퍼지고, 구토가 반복되면 즉시 연락합니다. 우상복부 통증·발열·황달도 진료가 필요합니다.

## PANCREAS

### 췌장염 의심

심한 지속 상복부 통증, 등으로 퍼지는 통증, 반복 구토.

## GALLBLADDER

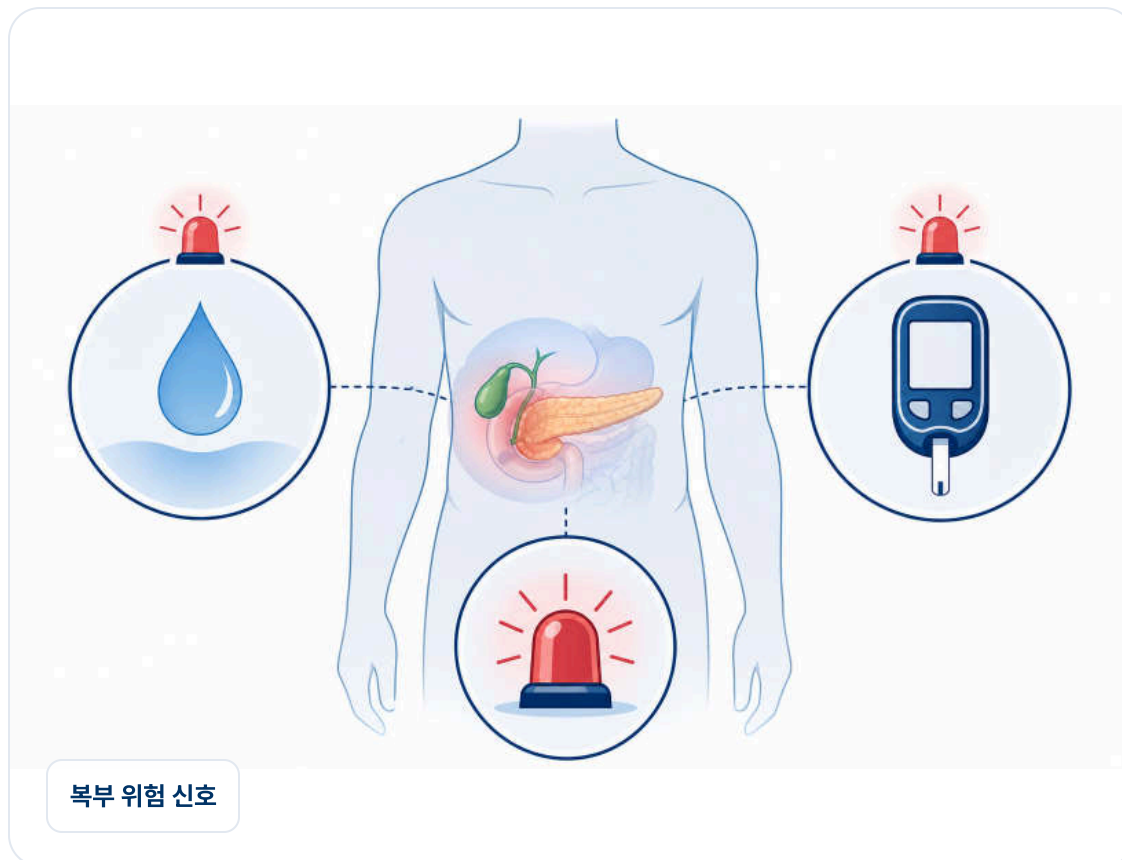
### 담낭질환

우상복부 통증, 발열, 노란 눈·소변 색 변화.

## ACTION

### 행동

증상을 참으며 다음 주사를 맞지 말고 먼저 진료에 알립니다.



# 구토·설사가 오래가면 약보다 수분이 먼저입니다

탈수는 어지럼, 신장기능 악화, 심한 무기력으로 이어질 수 있습니다.



탈수 예방

물을 못 마시고 토하거나 설사가 계속되면 치료를 잠시 조정해야 할 수 있습니다. 소변량 감소와 어지럼은 중요한 신호입니다.

## URINE

### 소변 감소

반나절 이상 소변이 매우 적거나 진하면 연락합니다.

## DIZZY

### 어지럼

서 있을 때 핑 돌거나 심장이 두근거리면 탈수를 의심합니다.

## MEDS

### 동반약

이뇨제·혈압약·당뇨약 복용자는 더 빨리 상담이 필요할 수 있습니다.

# 당뇨약을 같이 쓰면 저혈당을 확인합니다

GLP-1 계열 자체보다 인슐린·설폰요소제 병용 시 저혈당 위험이 올라갑니다.

식사량이 줄면 기존 당뇨약 용량이 상대적으로 강해질 수 있습니다.  
떨림, 식은땀, 심한 허기, 혼란감이 있으면 혈당 확인이 필요합니다.

## SYMPTOM

### 증상

식은땀, 손떨림, 심한 배고픔, 두근거림, 멍함.

## CHECK

### 측정

가능하면 혈당을 재고, 반복되면 약 조정을 상담합니다.

## RISK

### 고위험 약

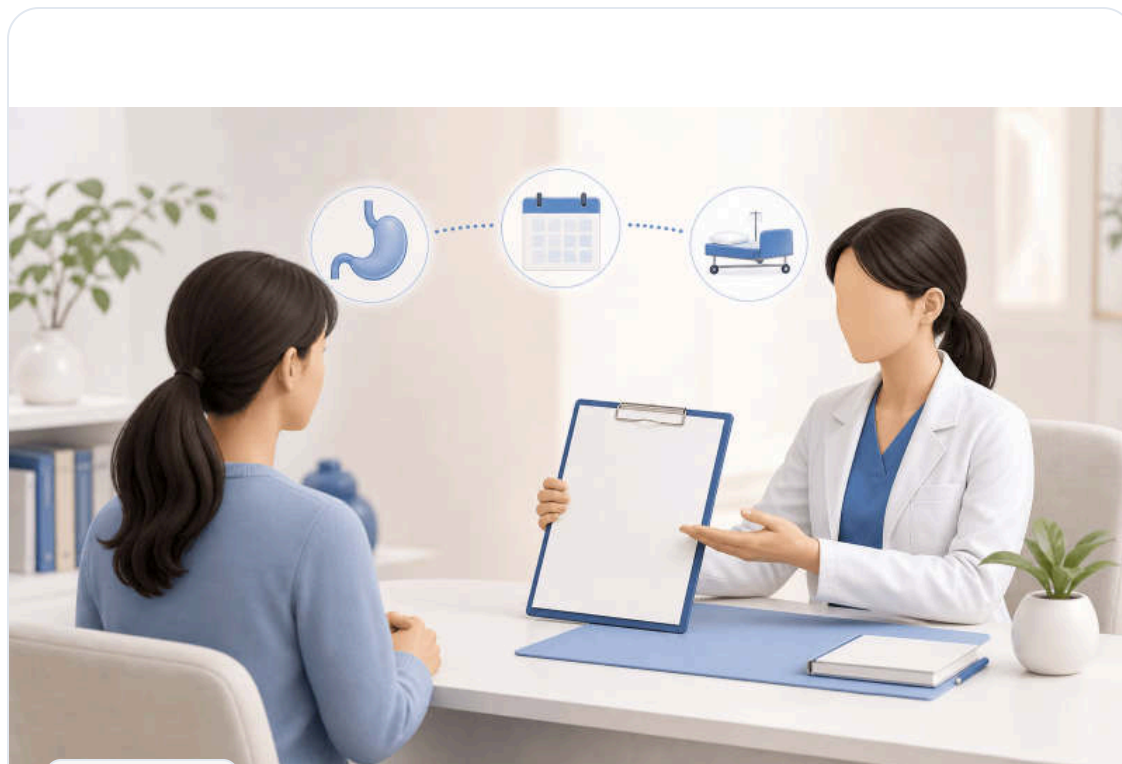
인슐린과 설폰요소제는 특히 진료실에 알려야 합니다.



혈당·약물 확인

# 수술·수면마취 전에는 주사약을 반드시 알립니다

위 배출 지연 때문에 마취·시술 전 관리 계획이 달라질 수 있습니다.



진료 전 알리기

내시경, 수술, 수면마취 예정이 있으면 약 이름과 마지막 주사일을 의료진에게 말해야 합니다. 갑상선 수질암/MEN2 병력도 처방 전 반드시 확인합니다.

## PROCEDURE

### 시술 전

내시경·수술·마취 전 약 이름과 마지막 주사일을 알립니다.

## THYROID

### 갑상선 병력

갑상선 수질암 또는 MEN2 개인·가족력은 중요한 금기입니다.

## ALLERGY

### 알레르기

호흡곤란, 얼굴·입술 부종, 전신 두드러기는 즉시 진료가 필요합니다.

## 이번 회차는 빨간불 구분

이번 주는 증상 이름보다 '지속성·강도·탈수 여부'를 기준으로 판단합니다.

**01** 심한 지속 복통과 반복 구토는 **바로 연락**합니다.

**02** 구토·설사가 지속되면 탈수와 신장기능을 봐야 합니다.

**03** 당뇨약 병용 시 저혈당 증상을 놓치지 않습니다.

**04** 시술·마취 전에는 마지막 주사일을 꼭 알립니다.

PHONE

031-893-4560

ADDRESS

경기 용인 수지구  
광교중앙로 298, 4층

SPECIALTY

소화기내과 · 일반내과  
5대암 검진



SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서  
같은 자료를 다시 볼 수 있어요